TRAUMA ABDOMINAL Y PÉLVICO

DR. MARTÍN VASQUEZ

MECANISMO CONTUSO

- Compresión, aplastamiento, cizallamiento y desaceleración (órganos fijos); órganos más lesionados: bazo, hígado e intestino delgado.

MECANISMO PENETRANTE

- Punzocortante (baja energía, laceraciones): hígado, intestino delgado, diafragma y colon.
- Arma de fuego (alta energía, cavitación, rotación, fragmentos): intestino delgado, colon, hígado y estructuras vasculares.

EXAMEN FÍSICO

- Inspección, auscultación, percusión y palpación; puede comprometerse por alcohol/drogas, lesión cerebral o medular, o lesión de costillas, columna o pelvis.

HERIDAS POR ARMA DE FUEGO

- Generalmente la mejor estrategia es la cirugía temprana.

MECANISMO DE LA FRACTURA PÉLVICA

- Compresión AP, compresión lateral y cizallamiento vertical; requieren la aplicación de una fuerza importante y se asocian a otras lesiones.



ESTUDIOS ESPECIALES EN TRAUMA CERRADO

- LPD: rápido, sin traslado, alta sensibilidad y baja especificidad; elegible en todos los pacientes.
- FAST: rápido, sin traslado, especificidad intermedia; depende del operador.
- TAC: tardada, requiere traslado, alta sensibilidad y especificidad; solo en hemodinámicamente normales.

Estudios Especiales en Trauma Cerrado

	LPD	FAST*	TAC
Tiempo	Rápido	Rápido	Tardado
Transporte	No	No	Se requiere
Sensibilidad	Alta	¿Alta?	Alta
Especificidad	Baja	Intermedia	Alta
Eligibilidad	Todos los pacientes	Todos los pacientes	Hemodinamica-mente normal

* Depende del operador

LAPAROTOMÍA EN TRAUMA CERRADO

- Hipotensión con sospecha de lesión visceral, aire libre, ruptura diafragmática, peritonitis o LPD/FAST/TAC con contraste positivos.

LAPAROTOMÍA EN TRAUMA PENETRANTE

- Hipotensión, lesión peritoneal o retroperitoneal, peritonitis, evisceración o estudios positivos.

MANEJO DE EMERGENCIA DE LA FRACTURA PÉLVICA

- Resucitación con líquidos; determinar si es abierta o cerrada y si hay lesiones perineales o genitourinarias.
- Determinar la necesidad de traslado e inmovilizar las fracturas pélvicas.

TRAUMA ABDOMINAL Y PÉLVICO

DR. MARTÍN VASQUEZ

ANATOMÍA EXTERNA
- Abdomen anterior, flancos y espalda.

REGIONES INTERNAS DEL ABDOMEN
- Cavidad peritoneal superior e inferior, cavidad pélvica (porción intraperitoneal y retroperitoneal) y espacio retroperitoneal.

IMPORTANCIA DEL TRAUMA ABDOMINAL
- La lesión intraabdominal no reconocida es una de las principales causas de muerte prevenible; el mecanismo determina qué órganos están probablemente lesionados.

HISTORIA EN TRAUMA CONTUSO
- Velocidad, punto de impacto, penetración, dispositivos de seguridad, posición y expulsión.

HISTORIA EN TRAUMA PENETRANTE
- Tipo de arma, distancia y número de heridas.

¿ES LA LESIÓN ABDOMINAL CAUSA DE CHOQUE?

- Evidencia de lesión abdominal por mecanismo, historia o evaluación; hipotensión; LPD o FAST positivos; ausencia de hemotórax masivo en la Rx de tórax.

TUBO GÁSTRICO
- Alivia la distensión y descomprime el estómago antes del LPD.
- Precaución: fractura de base de cráneo o faciales; puede inducir vómito o aspiración.

SONDA URINARIA
- Monitorea el gasto urinario, descomprime la vejiga antes del LPD y ayuda al diagnóstico (con precaución).

EXÁMENES DE SANGRE Y ORINA
- No indispensables; según severidad y estado hemodinámico (tipar y cruzar); prueba de embarazo, alcohol y drogas; hematuria evidente vs microscópica.

ESTUDIOS DE RAYOS X
- Cerrado: Rx AP de tórax y pelvis.
- Penetrante: Rx AP de tórax y abdomen con marcadores (si hay estabilidad hemodinámica).

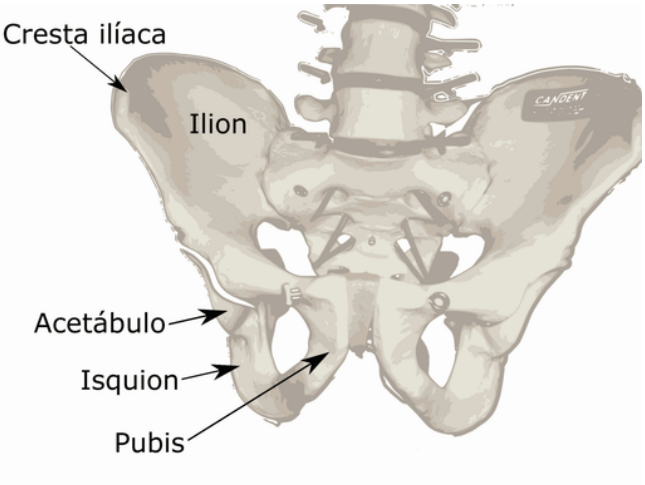
ESTUDIOS DE CONTRASTE
- Uretrografía, cistografía, urografía excretora, estudios gastrointestinales y TAC de abdomen.

HERIDAS TORÁCICAS BAJAS
- Exámenes seriados, toracoscopia, laparoscopia o TAC.

ARMA BLANCA EN ABDOMEN ANTERIOR
- Exploración local de la herida, LPD o exámenes seriados.

ARMA BLANCA EN ESPALDA O FLANCOS
- LPD, exámenes seriados o TAC con doble o triple contraste.

CLASIFICACIÓN DE LA FRACTURA PÉLVICA
- Abierta o cerrada.



SANGRADO PÉLVICO
- Proviene de los extremos óseos, los músculos pélvicos y las venas/arterias.

EVALUACIÓN DE LA FRACTURA PÉLVICA
- Inspección, palpación de la próstata y del anillo pélvico; discrepancia en la longitud de las extremidades, rotación externa y dolor a la palpación de la pelvis ósea.

MANEJO SEGÚN SANGRE INTRAPERITONEAL
- Con sangre intraperitoneal: laparotomía y control de la hemorragia.
- Sin sangre intraperitoneal: angiografía y dispositivo de fijación.